

《2018 年欧洲肿瘤内科学会临床实践指南:肝细胞癌的诊断、治疗和随访》摘译

吕佳昱¹译, 韩 涛²审校

(1 天津医科大学一中心临床学院, 天津 300070; 2 天津市第三中心医院 消化肝病科, 天津市人工细胞重点实验室, 天津市肝胆疾病研究所, 天津 300170)

关键词: 肝细胞癌; 诊断; 治疗; 欧洲; 诊疗准则

中图分类号: R735.7

文献标志码: B

文章编号: 1001-5256(2019)04-0766-03



扫一扫下载全文

An excerpt of hepatocellular carcinoma: ESMO clinical practice guidelines for diagnosis, treatment and follow-up (2018)

LYU Jiayu, HAN Tao. (Tianjin Medical University First Center Clinical College, Tianjin 300070, China)

Key words: hepatocellular carcinoma; diagnosis; therapy; Europe; practice guideline

2018 年, 欧洲肿瘤内科学会 (ESMO) 发布了肝细胞癌 (HCC) 的诊断、治疗和随访指南, 内容主要涉及 HCC 的发病率、流行病学及监测、诊断、分期和危险评估, 疾病管理以及随访等方面。现就指南中推荐要点进行摘译, 供临床参考。指南中的证据质量和推荐强度见表 1。

表 1 循证医学证据推荐分级系统

级别	说明
证据质量	
I	至少从一项设计良好的大型随机对照试验 (出现偏倚可能性很小) 或对质量好的无异质性的随机对照试验进行的高质量 Meta 分析中获得的证据
II	小型的随机对照试验或存在可疑偏倚的大型随机对照试验 (试验方法质量较低); 对上述类型试验或存在异质性的试验进行的 Meta 分析
III	前瞻性队列研究
IV	回顾性队列研究或病例对照研究
V	无对照组的研究, 病例报告或专家意见
推荐等级	
A	有力证据证明临床较大获益。强烈推荐
B	有力或中等强度的证据证明有效, 但一般来说, 临床获益不大。一般推荐
C	证明有效的证据不足或获益可能不超过风险或缺点 (如副作用, 成本等)。可选中等
D	强度的证据证明无效或存在不良后果。一般不推荐
E	有力证据证明无效或带来不良后果。从不推荐

doi:10.3969/j.issn.1001-5256.2019.04.012

收稿日期: 2019-03-05; 修回日期: 2019-03-05。

作者简介: 吕佳昱 (1991-), 女, 博士, 主要从事肝脏疾病的临床与基础研究。

通信作者: 韩涛, 电子信箱: hantaomd@126.com。

[本文首次发表于 Ann Oncol, 2018, 29 (Suppl 4): iv238-iv255]

1 发病率、流行病学及监测

(1) 慢性肝病的防治措施是降低 HCC 发生风险的基础, 包括新生儿普遍接种乙型肝炎疫苗 [I, A], 乙型肝炎和丙型肝炎患者早期接受抗病毒治疗 [III, A]。

(2) 成本效益研究提示无论何种病因的肝硬化均应进行 HCC 监测, 只要其肝功能和合并症允许进行根治性或姑息性治疗 [III, A]。

(3) 对于非肝硬化的肝炎患者同样推荐进行 HCC 监测, 尤其是血清 HBV DNA 载量 >10 000 拷贝/ml 的 HBV 感染者或存在桥接纤维化 (F3) 的慢性丙型肝炎患者 [III, A]。

(4) HCC 高危人群应每 6 个月进行腹部超声监测, 伴或不伴血清 AFP 检测 [I, A]。

2 诊断和病理学/分子生物学

(1) HCC 的诊断可依据病理学和 (或) 影像对比增强的检查结果 [III, A]。

(2) 肝硬化患者经增强 CT 或增强 MRI 检查时, 如直径 >1 cm 的结节出现 HCC 典型血管特征 (动脉期明显强化、门静脉期或延迟期消退) 则可确诊 [III, A]。

(3) 与多排螺旋 CT 相比, 多相 MRI 对存在典型血管特征 HCC 的诊断敏感性稍高 [III, B]。

(4) 血清 AFP 在 HCC 诊断流程中无作用 [III, A]。

(5) 基于弥散加权成像和肝胆增强剂造影等技术, MRI 有助于高风险结节的识别和分层 (缺乏典型影像学表现的 HCC 结节或高度异型增生结节) [IV, B]。

(6) HCC 和胆管细胞癌的血管影像在对比增强的超声造影下有重叠, 但最近的数据表明, 对比增强的超声造影可作为肝硬化患者无创诊断 HCC 的一种可选方法 [IV, B]。

(7) 当肿瘤活组织检查不能明确结节性质时, 可以考虑第 2 次肿瘤活组织检查或不同的造影增强成像方式或 (若满足切除条件) 直接根据肿瘤大小切除病灶 [IV, B]。

(8) 肿瘤活组织检查的病理学诊断依赖标准的 HE 染色和特殊

染色(如网状纤维染色),必要时还需结合免疫组化。

(9)因治疗方案不同,有必要将 HCC 与 ICC 合并胆管癌区分开,但在肿瘤活组织检查中可能看不到混合分化特征。除此之外,HCC 显著表达细胞角蛋白 CK19 被认为是预后不良的标志[Ⅳ,B]。

(10)高分化 HCC 活组织检查通常看不到明确恶性肿瘤征象(间质或血管侵犯),可通过组织学(小梁改变:小梁间隔增宽、假腺管结构、病灶内网状支架减少或消失、包膜形成)和细胞学(细胞核/质比增加如细胞核呈拥挤表象、细胞质嗜碱性物质增多)方面来确诊[Ⅲ,B]。

(11)组织学表现尚不明确时,可应用免疫组化:CD34 可用于评估窦周毛细血管化[Ⅳ,B]。

(12)进一步行免疫组化标志物检测有助于高分化 HCC 的诊断,包括 GS、GPC-3、CTC、EZH2 和 HSP70[Ⅳ,B]。

(13)合理组合免疫标志物可以提高诊断的敏感性,如将谷氨酰胺合成酶、磷脂酰肌醇蛋白聚糖 3 和热休克蛋白 70 结合(2/3 标志物阳性对 HCC 具有 70% 的敏感度和 100% 的特异度)[Ⅳ,B]。

3 分期和危险评估

(1)HCC 分期对疾病预后的判断和最佳治疗方案的制订有重要作用,分期评估包括肿瘤负荷、AFP 水平、肝功能、门静脉压力和患者体力状况[Ⅲ,A]。

(2)巴塞罗那(BCLC)分期系统已被普遍接受用于 HCC 预后的预测和治疗方案的制订。

(3)虽然有证据表明氟代脱氧葡萄糖摄取较高与肿瘤分化程度、大小、血清 AFP 水平和微血管侵犯相关,但目前证据不推荐 FDG-PET 扫描用于 HCC 临床分期[Ⅳ,D]。

(4)通常应用 Child-Pugh 评分系统(血清胆红素、血清白蛋白、腹水、凝血酶原时间和肝性脑病)来评估肝储备情况[Ⅲ,A]。

(5)在 Child-Pugh A 级 HCC 患者中,应用白蛋白-胆红素(ALBI)评分可以对预后进行评估:ALBI 1 级患者预后较好,ALBI 2 级患者预后较差,2 组中位生存期分别为 26 个月和 14 个月[Ⅳ,B]。

(6)临床上出现食管静脉曲张和(或)脾大伴血小板计数为 $100 \times 10^9/L$ 表明存在门静脉高压症,也可通过经颈静脉途径进行有创测量(肝静脉压力梯度 $>10 \text{ mm Hg}$)[Ⅲ,A]。

4 疾病管理

4.1 早期和中期 HCC 的管理

(1)不伴门静脉高压症的 Child-Pugh A 级患者适用小范围或大范围肝切除术[Ⅲ,B]。

(2)经过谨慎筛选的伴或不伴门静脉高压症的 Child-Pugh B 级患者可适用小范围肝切除术[Ⅲ,A]。

(3)肝硬化患者肝切除推荐采用腹腔镜方式入路[Ⅳ,A]。

(4)目前,米兰标准(单个病灶 $<5 \text{ cm}$ 或 ≤ 3 个病灶且每个病灶 $<3 \text{ cm}$,无肝外转移,无血管侵犯)是 HCC 肝移植受者选择的参考标准。肝移植推荐用于符合米兰标准的 HCC 患者,预期复发率低于 10%,5 年生存率为 70%[Ⅱ,A]。

(5)在众多 HCC 肝移植受者选择标准中,只有加利福尼亚

(UCSF)标准(单个病灶 $\leq 6.5 \text{ cm}$ 或 ≤ 3 个病灶最大病灶 $\leq 4.5 \text{ cm}$ 且肿瘤直径总和 $\leq 8 \text{ cm}$)得到前瞻性验证,取得与米兰标准相似的移植生存率。因此,超出米兰标准但符合 UCSF 标准的 HCC 患者也可以考虑应用肝移植[Ⅲ,B]。

(6)若移植等待时间较长(>3 个月),患者可以采用肝切除、肿瘤局部消融或经肝动脉化疗栓塞术(TACE)以最大限度地降低肿瘤进展的风险并为后续移植提供“桥梁”[Ⅲ,B]。

(7)肝移植、肝切除或局部消融后,不推荐对 HCC 患者进行辅助治疗[Ⅰ,E]。

(8)射频消融或微波消融可能被推荐作为极早期 HCC(BCLC 0 期)的一线治疗方案[Ⅱ,A]。

(9)因肿瘤位置行热消融术后有高风险局部治疗失败的患者,可选择高适形 HDR 放射性消融和立体定向放疗作为替代方案[Ⅲ,C]。

(10)外放射治疗可以控制骨转移患者的疼痛症状[Ⅲ,B]。

(11)无临床症状且肝功能良好的 BCLC A 期患者及肿瘤较小但不适合手术或局部消融治疗的早中阶段 BCLC B 期患者,行 TACE 治疗可延长总体生存期[Ⅰ,A]。

(12)除临床试验外,对于初次启动或重复 TACE 治疗,基于未知预测价值预后评分模型的治疗流程方案,目前不被推荐[Ⅲ,A]。

(13)碘油乳剂为栓塞剂的常规 TACE 是中期 HCC 患者的标准治疗方案,尽管应用载药微球为栓塞剂的药物洗脱微球 TACE 可以减少化疗产生的全身副作用[Ⅰ,C]。

(14)不推荐 TACE 与索拉非尼等全身治疗同时或序贯使用[Ⅰ,E]。

(15)对于中晚期 HCC 患者,不推荐将选择性内放射治疗作为一线治疗方案[Ⅰ,E]。

4.2 晚期 HCC 的管理

(1)随机对照试验显示,全身化疗未能提高 HCC 患者生存率,不建议将其作为晚期肿瘤患者的标准治疗方案[Ⅱ,C]。

(2)索拉非尼是晚期 HCC 患者、不适合局部治疗或经局部治疗后进展的 BCLC B 期患者的标准全身治疗方案,适用于肝功能良好且 ECOG PS 评分为 0-2 的患者[Ⅰ,A]。

(3)仑伐替尼已被证明疗效不劣于索拉非尼,可以作为晚期 HCC 的一线治疗。其适用于无主要门静脉侵犯、明显胆管侵犯、肿瘤占肝脏总体积 50% 以上情况的 HCC 患者(待欧洲食品药品监督管理局批准)[Ⅰ,A]。

(4)瑞戈非尼为对索拉非尼治疗耐受和疾病进展、肝功能良好且美国东部肿瘤合作组体能状况(ECOG PS)评分为 0-1 的晚期 HCC 患者的标准治疗方案[Ⅰ,A]。

(5)卡博替尼可以考虑用于经 1 种或 2 种全身治疗后疾病进展、肝功能良好且 ECOG PS 评分 0-1 的 HCC 患者(待欧洲食品药品监督管理局批准)[Ⅰ,A]。

(6)雷莫芦单抗可以考虑作为基线 AFP $\geq 400 \text{ ng/ml}$ 、肝功能良好且 ECOG PS 评分为 0-1 的 HCC 患者的二线治疗(待欧洲食品药品监督管理局批准)[Ⅰ,A]。

(7)纳武单抗和帕博利珠单抗的免疫治疗可考虑用于对酪氨酸激酶抑制剂不耐受或疾病进展的 HCC 患者(待欧洲药品管理

局批准),未来需更多随机对照试验结果来明确具体推荐方案[Ⅲ,B]。

5 随访、长期影响和存活率

(1)应用动态增强CT或MRI评估治疗后是否存在活性肿瘤,并定义为动脉期摄取造影剂[Ⅲ,A]。

(2)推荐使用实体瘤治疗疗效评价标准的修订标准(mRECIST)对HCC局部治疗的应答/进展进行评估[Ⅲ,B]。

(3)虽然mRECIST标准需要进一步前瞻性试验验证,但可推荐用于日常临床实践,其不仅考虑到肿瘤的直径,还考虑到治疗决策中病灶的活性[Ⅲ,B]。

(4)有限临床证据表明mRECIST比RECIST v1.1能更准确地预测患者总体生存期[Ⅳ,B]。

(5)接受根治性治疗(肝切除或射频消融)的患者随访应包括临床评估肝失代偿情况和肿瘤早期复发情况。根据动态增强

CT或MRI结果,建议前2年每3个月评估1次,之后每6个月评估1次[Ⅲ,A]。

(6)接受TACE或全身治疗的终末期HCC患者随访应包括临床评估肝脏失代偿情况和肿瘤进展情况。根据动态增强CT或MRI结果,建议每3个月评估1次以指导治疗抉择[Ⅲ,A]。

引证本文:LYU JY, HAN T. An excerpt of hepatocellular carcinoma: ESMO clinical practice guidelines for diagnosis, treatment and follow-up (2018) [J]. J Clin Hepatol, 2019, 35 (4): 766-768. (in Chinese)

吕佳昱,韩涛.《2018年欧洲肿瘤内科学会临床实践指南:肝细胞癌的诊断、治疗和随访》摘译[J].临床肝胆病杂志,2019,35(4):766-768.

(本文编辑:王亚南)

· 国外期刊精品文章简介 ·

卡维地洛与非选择性β受体阻滞剂治疗成人肝硬化食管胃底静脉曲张效果比较

【据《Cochrane Database Syst Rev》2018年10月报道】题:比较卡维地洛与非选择性β受体阻滞剂治疗成人肝硬化食管胃底静脉曲张的结局(作者Zacharias AP等)

非选择性β受体阻滞剂被推荐用于预防肝硬化门静脉高压患者的食管胃底静脉曲张出血。卡维地洛是非选择性β受体阻滞剂,还可阻断α1受体,因此在降低门静脉压力和减少上消化道出血风险方面可能优于非选择性β受体阻滞剂。

Zacharias等的研究旨在评估卡维地洛与非选择性β受体阻滞剂治疗成人肝硬化食管胃底静脉曲张的利和弊。研究者检索了Cochrane肝胆组对照试验注册库、Cochrane对照试验中心注册库(CENTRAL)、Medline、Embase、LILACS和SCI数据库,结合人工检索。纳入了比较卡维地洛与非选择性β受体阻滞剂的随机临床试验,不论发表状态、盲法或语言;还纳入了有关成人肝硬化伴食管胃底静脉曲张患者进行上消化道出血一级和二级预防的试验。主要结局指标为病死率、上消化道出血和严重不良事件。用相对危险度(RR)或均值差(MD)以及各自95%可信区间(95%CI)呈现效应量,用I²值评估异质性。通过Cochrane肝胆领域评估偏倚控制和GRADE评估证据质量。

10项随机临床试验被纳入,包括810例肝硬化伴食管静脉曲张患者。干预组为卡维地洛与普萘洛尔($n=9$)或纳多洛尔($n=1$)。6项短期试验,平均6周(1~12周);4项长期试验,平均13.5个月(6~30个月)。3项试验评估一级预防;3项试验评估二级预防;4项试验评估一级和二级预防。7项试验,507例参与者,提供病死率数据;其中,4项试验无死亡事件。254例卡维地洛治疗的患者中16例死亡;253例普萘洛尔或纳多洛尔治疗的患者中19例死亡($RR=0.86, 95\%CI:0.48\sim1.53; I^2=0\%$,证据质量低)。卡维地洛与非选择性β受体阻滞剂相比,上消化道出血($RR=0.77, 95\%CI:0.43\sim1.37; I^2=45\%$,证据质量极低)和严重不良事件发生风险($RR=0.97, 95\%CI:0.67\sim1.42; I^2=14\%$,证据质量极低)之间似乎无差异。长期试验中,存在更多的死亡、上消化道出血和严重不良事件,但由试验时间长短的亚组分析,尚无足够信息确定两者之间是否存在差异。评估一级或二级预防的试验中,也尚无足够的信息发现两者的差异。与对照组相比,非严重不良事件风险似乎无差异($RR=0.55, 95\%CI:0.23\sim1.29; I^2=88\%$,证据质量极低)。与对照组相比,卡维地洛可显著降低肝静脉压力梯度的绝对值($MD=-1.75\text{ mm Hg}, 95\%CI:-2.60\sim-0.89; I^2=0\%$,证据质量低)和百分比($MD=-8.02\%, 95\%CI:-11.49\%\sim-4.55\%; I^2=0\%$;证据质量低)。然而,作者没有观察到未能达到足够血流动力学应答的患者数量($RR=0.76, 95\%CI:0.57\sim1.02; I^2=42\%$,证据质量极低)和临床结局随之减少。

尽管卡维地洛更有效地降低肝静脉压力梯度,但作者发现两者之间在病死率、上消化道出血、严重或非严重不良事件方面无明显差异。但由于证据质量低或极低,这些结论尚不确定。还需从足够大样本量、长期、双盲、随机的临床试验中获得更多的证据,以评估临床和血流动力学的结局。

(北部战区总医院消化内科 安阳 祁兴顺 郭晓钟 报道)